SDD 151 Sujet n°1

Spécialité : Urgence / Réanimation

Date :02/01/2024
Auteur : Romain TYMEN (DESMIR Brest)
Relecteur(s) : Marin Caumartin (DESMIR Paris) Sébastien VILLARD (DESMIIC Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Urgence vitale
Domaine d'apprentissage secondaire	Prise en charge thérapeutique
Item(s) en lien avec la station	Anaphylaxie
Situation(s) de départ en lien avec la station	151- Oedème de la face et du cou
Matériel nécessaire à la station	1 patient acteur
Contexte de la station	Hospitalisation.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin d'astreinte dans un hôpital périphérique.
Nous sommes dimanche matin, M Le Gall, 48 ans, sans antécédent notable, vient d'être transféré des urgences dans le service d'orthopédie, en hébergement pour la dermatologie.
Le bilan des urgences conclut à une dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante du membre inférieur droit.
Les paramètres vitaux étaient dans les normes, les données biologiques mettaient en évidence un unique syndrome inflammatoire biologique. Devant l'importance de l'étendue de la dermo-hypodermite, il est convenu d'une hospitalisation pour surveillance.

Anna, l'infirmière qui s'occupe du patient vous appelle :
"Bonjour, je suis infirmière en orthopédie, Mr Le Gall est hospitalisé chez nous pour érysipèle. Depuis 5 minutes, il dit avoir du mal à respirer".
Comme vous êtes dans le service à côté, vous arrivez sans lui laisser le temps de raccrocher.
Avant votre arrivée, Anna a pris les paramètres vitaux du patient :
Pression artérielle : 115/75 mmHg, fréquence cardiaque 135 bpm, SpO2 92% en air ambiant, T 37,3°C.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes :
- Interroger le patient
- Émettre un cadre diagnostique à voix haute
- Effectuer la première intervention thérapeutique
- Transmettre les informations réunies au réanimateur de garde

Vous ne devez pas :
- Ausculter le patient
- Administrer de médicament (considérez que la verbalisation du médicament équivaut à l'administration)

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche un rash cutané	1 pt	☐
2.	Recherche un oedème des parties molles OU des signes de lutte respiratoire.	1pt	☐
3.	Recherche une atteinte hémodynamique tachycardie OU signe d'hypoperfusion périphérique	1 pt	☐
4.	Recherche des antécédents allergiques ET la réaction provoquée	1pt	☐
5.	Rechercher l'introduction récente de médicaments	1 pt	☐
6.	Identifie la perfusion en cours d'AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE	1 pt	☐
7.	Identifie le degré d'anaphylaxie : stade III	1 pts	☐
8.	Arrête la perfusion d'AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE	1 pts	☐
9.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées - Présentation de l'interlocuteur et de sa situation	1 pt	☐
10.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées - Mentionne un oedème des voies aériennes supérieures / un bronchospasme	1 pt	☐
11.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées - Mentionne un Rash cutané	1 pt	☐
12.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées - Mentionne la tachycardie	1 pt	☐
13.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées - Mentionne le diagnostic d'anaphylaxie	1 pt	☐
14.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées - Émet la notion d'urgence vitale	1 pt	☐
15.	Appelle le réanimateur de garde pour communiquer des informations précises et structurées	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

	- Demande une évaluation par le réanimateur / un transfert en réanimation		
Communications et attitudes			
1.	**4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

2.	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

3.	**6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

TOTAL (max 20 items)	**18 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Chez un patient jeune sans antécédent présentant une difficulté respiratoire associée à un oedème des parties molles doit faire évoquer en première intention un choc anaphylactique.

La première chose à identifier est l'agent allergène, et stopper son administration (rechercher tout contact récent et nouveau avec un médicament).

Par la suite, la thérapeutique principale à mettre en place est une injection d'Adrénaline IV ou IM. Ici l'antibiothérapie étant administrée par voie intraveineuse, il faut conserver la perfusion et y administrer l'adrénaline en priorité par voie intraveineuse.

Devant l'atteinte respiratoire sévère, il conviendra d'administrer des aérosols de Bêta 2 mimétiques pour lutter contre un bronchospasme.

Vient enfin la nécessité de surveillance dans un secteur scopé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes médecin d'astreinte dans un hôpital périphérique.
Nous sommes dimanche matin, Mr Le Gall, 48 ans, sans antécédent notable, vient d'être transféré des urgences dans le service d'orthopédie, en hébergement pour la dermatologie.
Le bilan des urgences conclut à une dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante.
Les données paracliniques étaient satisfaisantes (constantes normales, pas de désordre biologique). Devant l'importance de l'étendue de la dermo-hypodermite, il est convenu d'une hospitalisation pour surveillance.

Anna, l'infirmière qui s'occupe du patient vous appelle :
"Bonjour, je suis infirmière en orthopédie, Mr Le Gall est hospitalisé chez nous pour érysipèle. Depuis 5 minutes, il dit avoir du mal à respirer".
Comme vous êtes dans le service à côté, vous arrivez sans lui laisser le temps de raccrocher.
Avant votre arrivée, Anna a pris les constantes du patient :
TA : 115/75 mmHg, FC 135 bpm, Sat 92% en AA.

Plan de la station ECOS :

Patient allongé sur son lit d'hôpital

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Aidez-moi Dr, j'ai du mal à respirer!"

Identité du patient :

Mr Jacques LE GALL, 48 ans, 170 cm, 80 kg.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Mode de vie :

Transporteur de fond, marié avec 2 enfants de 10 et 15 ans, 1 chien et un chat. Tabac ½ paquet par jour depuis 30 ans, alcool occasionnel. **Pas d'allergie connue.**

Comportement global :

Difficultés à respirer de plus en plus importantes, mime une sensation d'étouffement.
Parle initialement avec des phrases, puis plus l'entretien avance plus les réponses sont courtes et brèves.
De la position allongée initiale, passage en position assise.

Antécédents personnels :

1 épisode d'infection urinaire masculine traité par CEFTRIAXONE

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

Pas de traitement au long cours.

En perfusion : AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE 2 g, début de perfusion dans le service il y a 15 minutes. Le patient spécifie "on m'a passé de l'AUGMENTIN pour l'infection de la jambe. C'était juste avant que j'ai du mal à respirer" si la question de la prise de nouveaux médicaments est posée.

Symptômes positifs :

Important oedèmes des parties molles, notamment de la langue et des lèvres.
Difficultés respiratoire majeure confinant à une discussion par mots seulement. Toux importante associée. Wheezing expiratoire.
Rash cutané diffus urticarien (le patient décrit des plaques rouges apparues depuis une quinzaine de minutes).
Pas de signe d'hypoperfusion périphérique.
Pas de douleur.

Constantes :

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Tension artérielle : 115/75 mmHg, Fréquence cardiaque 135 bpm, SpO2 92% en Air ambiant. Fréquence respiratoire 28 cycles par minute

Questions de relance :

05 min : si le candidat ne l'a pas fait avant, lui demander de contacter le réanimateur de garde.

06 min : si au cours de l'entretien avec le réanimateur de garde le candidat ne formule pas d'hypothèse diagnostique, lui demander d'émettre une hypothèse.

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Chambre d'hospitalisation classique avec un lit.
Patient allongé sur son lit.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Pas de matériel spécifique.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)